DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: ANGY VIVIANA GOMEZ MARIN **Identificación** CC 1088004325
Edad: 36 AÑOS **Empresa:** FIDEICOMISOS PATRIMONIALES AUTONOMOS FIDUSIARIA LA PREVISORA S.A FOMAG-2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 10/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	W21	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: K295 GASTRITIS CRONICA NO ESPECIFICADA

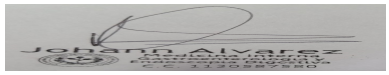
Dx Postoperatorio: K295 GASTRITIS CRONICA NO ESPECIFICADA

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 10/11/26 **Fecha Final** 10/11/26
Hora Inicio 11:55:00 **Hora Final** 12:08:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: Melenas?
ESOFAGO: Normal hasta tercio distal. Cardias franqueable.
ESTOMAGO: Explorado hasta píloro incluyendo retrovisión para pequeña curva y fondo gástrico normales.
Mucosa corporal normal. En antro se observaron algunas erosiones prepilóricas sin úlceras, sin sangrado.
No se evidencia sangrado activo ni reciente en este estudio. Motilidad antral normal. Píloro franqueable.
DUODENO: Normal hasta segunda porción.
BIOPSIAS: No se toma por evento agudo.
***CONCLUSION:
1. GASTRITIS ANTRAL EROSIVA LEVE

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***